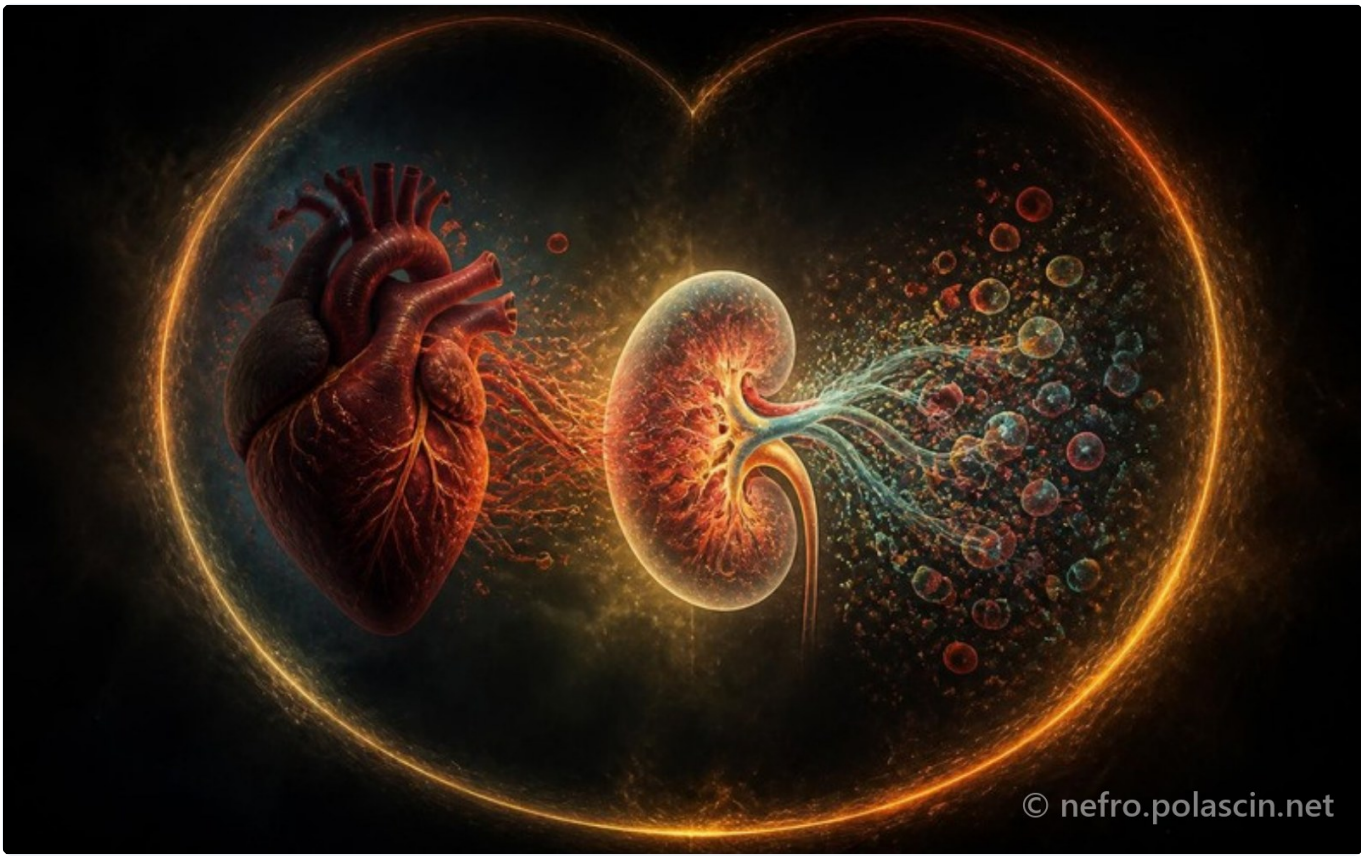
CKM syndróm konečne ako „jeden rámec“: čo znamenajú nové ACC/AHA/ADA/ASN usmernenia pre nefrologickú prax

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 01.07.2026



Ilustračná scéna. Spoločný rámec znamená, že sa už nehodnotí každý orgán zvlášť a oblička stojí v jeho strede.

Chronická choroba obličiek (CKD) zriedka existuje izolovane. U väčšiny pacientov sa prelína s diabetom, metabolickými rizikami, obezitou, dyslipidémiou a kardiovaskulárnym ochorením. V praxi potom vzniká typický problém: každý odbor rieši „svoje“ diagnózy, ale pacientovo riziko je spoločné a rastie naprieč orgánmi.

Nové usmernenia pre **kardiovaskulárno-obličkovo-metabolický (cardiovascular-kidney-metabolic, CKM) syndróm** chcú tieto pohľady prepojiť. CKD v nich už nie je iba renálnym koncom reťazca, ale súčasťou širšieho kardiovaskulárno-metabolického obrazu.

Čo je cieľom CKM usmernení

Podľa spracovania na Medscape sú publikované dve súvisiace časti:

1. **„Guideline-at-a-glance“ v JACC**, stručný prehľad na rýchlu orientáciu.
2. **Komplexné usmernenie AHA/ACC/ADA/ASN** pre prevenciu, detekciu, vyhodnotenie a manažment CKM syndrómu.

Význam usmernení je aj v tom, že prinášajú **nový, explicitný rámec** pre CKM syndróm, nie ďalší súhrn jednotlivých diagnóz riešených izolovane v samostatných odboroch.

Ako to môže vyzerať v nefrologickej ambulancii

Nefrológ často stojí pred otázkou, ako prepojiť:

- renálne riziko (pokles eGFR, albuminúria, progresia),
- kardiovaskulárne riziko (KV príhody, hospitalizácie, zlyhávanie srdca),
- metabolické riziko (diabetes, obezita, dyslipidémia).

CKM prístup podporuje pracovný model, v ktorom sa mapa rizika pacienta nebuduje oddelene, ale naraz. Prakticky to môže znamenať:

- mať pri každej významnej návšteve „spoločný cieľ“ (CKD nie je len cieľová hodnota eGFR, ale aj rizikový marker pre kardiovaskulárnu a metabolickú os),
- pri hodnotení pacienta zvažovať, či ide skôr o „čisto renálny problém“, alebo o CKM obraz s dominantnou kardiometabolickou zložkou,
- plánovať následné kroky v tom istom logickom slede (detekcia a triedenie rizika → hodnotenie → manažment a sledovanie).

Prečo je CKM rámec pre nefrológa dôležitý

1. **Prevencia progresie je často aj prevenciou KV príhod.** Ak sa sústredíte len na renálny cieľový ukazovateľ (endpoint), môžete prehliadnuť dominantnú zložku rizika.
2. **Liečba je komplexná a interdisciplinárna.** CKM rámec prirodzene vytvára priestor na koordináciu cieľov s diabetológom a kardiológom.
3. **Zmysel dávajú „spoločné“ ukazovatele.** Nielen eGFR, ale aj rizikové profily, albuminúria, krvný tlak, metabolické parametre a celkové kardiovaskulárne riziko.

Čo si z usmernení odniesť ako „nefrologický pracovný postup“

Usmernenia sú zamerané na prevenciu, detekciu, vyhodnotenie a manažment, preto sa dajú premeniť na vlastný interný postup, napríklad takto:

- **Detekcia:** u každého pacienta s CKD aktívne pátrať po dominantnej kardiometabolickej osi (nielen podľa diagnóz, ale aj podľa rizikového profilu).
- **Vyhodnotenie:** zjednotiť dokumentované ciele tak, aby nefrológ riešil renálny aj kardiovaskulárny rozmer v prepojenom pláne.
- **Manažment a sledovanie:** plánovať kontroly tak, aby sledovali progresiu aj rizikové faktory naprieč osami, nie iba laboratórny trend eGFR.

Zdroj: *Chiadi E. Ndumele, Fatima Rodriguez, Gurusher S. Panjrath a kol., „Cardiovascular-Kidney-Metabolic (CKM) Guidelines (ACC/ADA/AHA/ASN)“, JACC (2026); spracované v Medscape Reference. Medscape · JACC – guideline-at-a-glance · JACC – komplexné usmernenie.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=ckm-syndrom-usmernenia-acc-aha-ada-asn-nefrologia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.